

●肺癌の治療

・気管支鏡を用いて肺組織または腫瘍の一部を採取 → 経気管支肺生検 (TBLB)

○Performance Status (PS)

- ・PS0: 全く問題なく活動できる。発症前と同じ日常生活が制限なく行える。
- ・PS1: 肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。
- ・PS2: 歩行可能で、自分の身の回りのことは全て可能だが、作業はできない。日中の50%以上はベッド外で過ごす。
- ・PS3: 限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の50%以上をベッドカイスで過ごす。
- ・PS4: 全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドカイスで過ごす。

○肺がんの病理学的分類

●非小細胞肺がん - 最も多い!

- ・腺がん: 末梢型、喫煙との関連は不明。悪性度+、化学療法・放射線療法の感受性は有効。症状が出にくい。
- ・扁平上皮がん: 肺門型、喫煙との関連あり。悪性度+、化学療法・放射線療法の感受性は有効。咳や血痰などの症状。
- ・大細胞がん: 末梢型、喫煙との関連は不明。悪性度+、化学療法・放射線療法の感受性は有効。悪性度が高いものがある。

●小細胞肺がん

- ・小細胞がん: 肺門型、喫煙との関連はあり。悪性度+++、化学療法・放射線療法の感受性は著効。最も悪性度が高い。
- *治療学的に、非小細胞肺がんと、小細胞肺がんに分類する。

・EGFR

腺がん

アジア人 女性 非喫煙者

○非小細胞肺がんの治療

●非小細胞肺がんの術後化学療法

- ・病変全体径 > 2cmの術後病理病期1A/1B/2Aの、完全切除、腺癌/非腺癌症例に対して、テガフル・ウラシル配合剤療法を行うよう推奨する。
- ・術後病理病期2-3A期、完全切除例に対して、シスプラチン併用療法を行うよう推奨する。
- ・臨床病期3A期非小細胞癌の治療方針は、呼吸器外科医を含めた集学的治療グループでの検討を行うよう推奨する。

●肺癌の薬物療法

◎化学療法: 細胞障害性化学療法: シスプラチン、カルボプラチン、パクリタキセル、ドセタキセル、ナベルピン、イリノテカン、TS-1

◎分子標的薬剤:

- ・チロシンキナーゼ阻害剤
→ 全身状態が不良な患者には施行はいい。
→ 効果や有害事象に人種差がある。
 - ・EGFR遺伝子変異: ゲフィチニブ、エルロチニブ、アファチニブ、オシメルチニブ
 - ・ALK融合遺伝子: クリゾチニブ、アレクチニブ → 皮疹、間質性肺炎
 - ・ROS1融合遺伝子: クリゾチニブ
 - ・BRAF遺伝子変異: ダブラフェニブ、トラメチニブ
- ・血管新生阻害剤: ベバシズマブ

◎免疫チェックポイント阻害剤: PD-1抗体: ニボルマブ、ペンブロリズマブ

PD-L1抗体: アテゾリズマブ、デュルバルマブ

●化学放射線療法: それぞれ単独より5年生存率が高い。(5年生存率15%)

- ・切除不能局所進行性非小細胞肺癌、全身状態良好 (PS0-1) の患者に対して、化学放射線療法を行うよう推奨する。
- ・化学放射線療法においてプラチナ製剤と第三世代以降の細胞障害性抗癌剤併用を行うよう推奨する。

ⅢB/Ⅳ期の標準治療

・抗がん薬への反応: 小cell癌 > 非小cell癌

○小細胞肺癌の治療

→ 非小cell癌増殖進行が速い。腫瘍マーカー: NSE, proGRP

●小細胞肺癌の病期分類

- ・限局型; LD: 1) 病巣が片側胸郭内に限局する。

2) 原発巣と同一照射野に含むことが可能な範囲で、以下を含む。(両側縦隔、同側肺門、同側鎖骨上リンパ節)

- ・進展型; ED: 上記のLDの範囲を超えるもの。

●限局型小細胞肺癌 (PS0-2)

- ・限局型小細胞肺癌 (PS0-2) に対して、化学放射線療法を行うよう推奨する。(放射線療法は加速温分割照射)
- ・限局型小細胞肺癌 (PS0-2) に対する放射線療法と同時併用する際の薬物療法は、シスプラチン+エトポシド療法を行うよう推奨する。

●進展型小細胞肺癌 (PS0-2、70歳以下)

- 延命効果が証明されている。進展型の小細胞癌には放射線は行わない!
- ・進展型小細胞肺癌 (PS0-2、70歳以下) にはシスプラチン+イリノテカン療法を行うよう推奨する。
- ・進展型小細胞肺癌 (PS0-2、70歳以下) にはシスプラチン+エトポシド療法を行うよう推奨する。
- ・進展型小細胞肺癌 (PS0-2、71歳以上) に対してシスプラチンの一括投与が可能な場合、シスプラチン+エトポシド療法を行うよう推奨する。
- ・進展型小細胞肺癌 (PS0-2、71歳以上) に対してシスプラチンの一括投与が困難な場合、カルボプラチン+エトポシド療法またはSplitPEを行うよう推奨する。
- ・進展型小細胞肺癌 (PS0-1) にはプラチナ製剤併用療法+PD-L1阻害薬を行うよう推奨する。

・中皮腫: アスベスト暴露。増殖している。胸膜・腹膜・心膜に発生。治療抵抗性。胸水中のヒyaluron酸が上昇。